

你的胰臟初老了嗎？

揭開沉默器官的衰退真相

章醫師 | 消化內科・胰臟健康管理 | 2026 年 7 月 | 閱讀時間約 8 分鐘

摘要

胰臟被稱為「沉默的器官」，一旦發出求救聲，往往已相當嚴重。本文從一位 25 歲卻擁有「70 歲胰臟」的真實案例出發，帶你認識胰臟老化的警訊、外分泌與內分泌的雙重角色，以及為什麼「影像正常」不代表功能無虞。學會理性覺察，才能在遺憾發生前，聽見胰臟的低語。

在診間的日常裡，我常看見許多患者帶著厚厚一疊「正常」的報告，眼神卻透著無助。他們有的做過好幾次胃鏡，有的連大腸鏡都排了，結果卻總是被告知：「沒事，就是功能性消化不良。」但他們心裡的苦，只有自己知道——那是揮之不去的脹氣，以及不明原因、看著體重計數字往下掉的恐懼。

每當這時，我總會輕聲提醒：「有沒有可能，是躲在胃後方那個沉默的『胰臟』，正在向你求救？」胰臟雖然沉默，但它一旦選擇「罷工」，往往代表情況已經相當嚴重。今天，我想與你聊聊胰臟的健康管理，讓我們一起學會傾聽這個器官的求救聲。

真實故事：25 歲的她，卻擁有一顆 70 歲的胰臟

診間的門輕輕推開，25 歲的 M 小姐坐了下來，臉色有些蒼白。她原本該是青春正盛的年紀，卻被長期的腹脹折磨得毫無生氣。

“「章醫師，我真的沒辦法了。這一年來我看了好多醫生，胃鏡照了兩次，大腸鏡也做了。醫師都說我只是壓力大、腸胃蠕動慢，開了消脹氣的藥給我。但我現在連飯都吃不下，體重掉了快五公斤，難道真的是我心理作用嗎？」

我看著她消瘦的身影，心裡浮起一絲警覺。我請她躺在檢查床上，塗上微涼的傳導膠，超音波探頭在她的上腹部緩緩滑動。螢幕上的影像逐漸清晰，但我卻心頭一沉。

在超音波底下，我看到的不是一顆充滿活力、飽滿的胰臟，而是一顆顯得「瘦弱萎縮」、邊界模糊且質地不均的器官。那模樣，看起來竟然像是一位 70 歲長輩的胰臟。

後續的血液檢查證實了我的憂慮。M 小姐的胰臟功能檢查結果顯示，她的消化酵素分泌能力竟然只有同齡人的五分之一。不僅如此，因為脂肪吸收障礙，她的體內嚴重缺乏脂溶性維生素（特別是維生素 D）。這就是典型的「胰臟初老」。雖然她才 25 歲，但她的胰臟已經提前進入了衰退期。這不是腸胃炎，而是她的胰臟正在枯萎。

Ⅰ 今天要回答的問題：如何察覺胰臟的「求救訊號」？

胰臟老化不是老年人的專利。在我的門診中，像 M 小姐這樣的個案並非孤例。為了讓大家不再走冤枉路，我有兩個核心問題想與你探討：

Q 當胰臟開始「初老」或功能崩壞時，身體會發出哪些容易被忽視的警訊？

Q 為什麼有些人的影像檢查（如 CT 或 MRI）看起來完全正常，但胰臟功能卻可能已經毀壞殆盡？

胰臟老化的兩大警訊

隨著年齡增長或機能衰退，胰臟的「雙重任務」將雙雙失守：



外分泌衰退：消化亮紅燈

(消化酵素分泌減少)

- 長期脹氣與腹部不適 (吃消脹氣藥無效)
- 不明體重減輕
- 大便習慣改變 (軟便、脂肪便/油便)

內分泌衰退：血糖溜滑梯

(胰島素分泌減少或效率變差)

- 血糖波動變大 (異常升高或下降)
- 容易感到疲倦、無力
- 經常性頭暈

胰臟老化的兩大警訊——外分泌衰退讓消化亮紅燈，內分泌衰退則使血糖溜滑梯，雙重任務雙雙失守。

為什麼大家容易誤解？胰臟健康的三大盲點

胰臟之所以被稱為「遺憾的器官」，是因為大眾對它存在太多先入為主的誤區。我整理了一張表格，希望能幫你糾正這些錯誤觀念。

常見誤區

章醫師的真心話

不喝酒就不會得胰臟病？

酒精雖是常見原因，但腫瘤、免疫系統攻擊、基因遺傳（如 PRSS1 突變）以及高三酸甘油酯也是關鍵推手。千萬別因為滴酒不沾就掉以輕心。

胰臟出問題就要徹底控油？

這是天大的誤會！除了急性發炎期，長期慢性疼痛、胰臟功能不全者若過度控油，會加劇營養失衡。你需要的是適量補充優質油脂與醫用胰臟酵素，否則體重會掉得更快。

CA19-9 升高就是胰臟癌？

CA19-9 只是「配角」。水泡（肝／腎水泡）、身體發炎、甚至肺癌或大腸癌都可能讓它上升。反之，早期胰臟癌患者有 10-15% 的人該數值永遠正常。

醫師怎麼思考？胰臟的「雙面特工」身份

在醫學上，我常把胰臟比喻為身體裡的「雙面特工」，它過著兩種完全不同、卻同樣重要的生活：

外分泌（消化小工人）：脂肪酶的唯一生產線

胰臟分泌的胰液含有澱粉酶、蛋白酶與脂肪酶。其中「脂肪酶」最為關鍵，因為全身只有胰臟能生產它。如果這條生產線停擺，你攝取的油脂會直接排出，形成「油便」。

這裡有個有趣的知識：胰液中的碳酸氫鈉就像是「氛圍製造機」。它能中和胃酸，營造出鹼性的「大環境」，讓消化酵素能安心工作。如果環境不對（pH 值失衡），再多的酵素也發揮不了作用。

此外，胰臟裡的蛋白酶非常「躁動」。為了自我保護，它們平時以無活性的「蛋白酶原」形式存在，一旦在小腸被啟動，就會像骨牌效應一樣連鎖反應。如果基因出錯讓它們提前在胰臟內「內鬨」，就會引發自我消化，造成胰臟炎。

內分泌（血糖調控中心）：胰島素與昇糖素的平衡者

胰臟也是血糖的糾察隊。它分泌胰島素（降血糖）與昇糖素（升血糖）。當這個調控中心受損，你會發現血糖開始像雲霄飛車般不穩，並伴隨疲倦、多尿、口渴與異常飢餓感。

醫學的證據：影像與功能的「平行時空」

很多病人不解：「章醫師，我的 CT 報告說胰臟大小正常，為什麼我還會拉肚子、血糖高？」我必須告訴你：胰臟的影像與功能，常常處於「平行時空」。看看我診間的兩位 X 先生與 Y 先生：

X 先生

38 歲・影像正常，功能卻已受損

影像檢查看起來非常正常。但他的三酸甘油酯平常高達 800-900（正常值 150 以下），長期導致胰臟慢性受損，糖化血色素（HbA1c）已高達 10，且吃油膩食物就拉油便。

Y 先生

36 歲・影像異常，功能卻仍正常

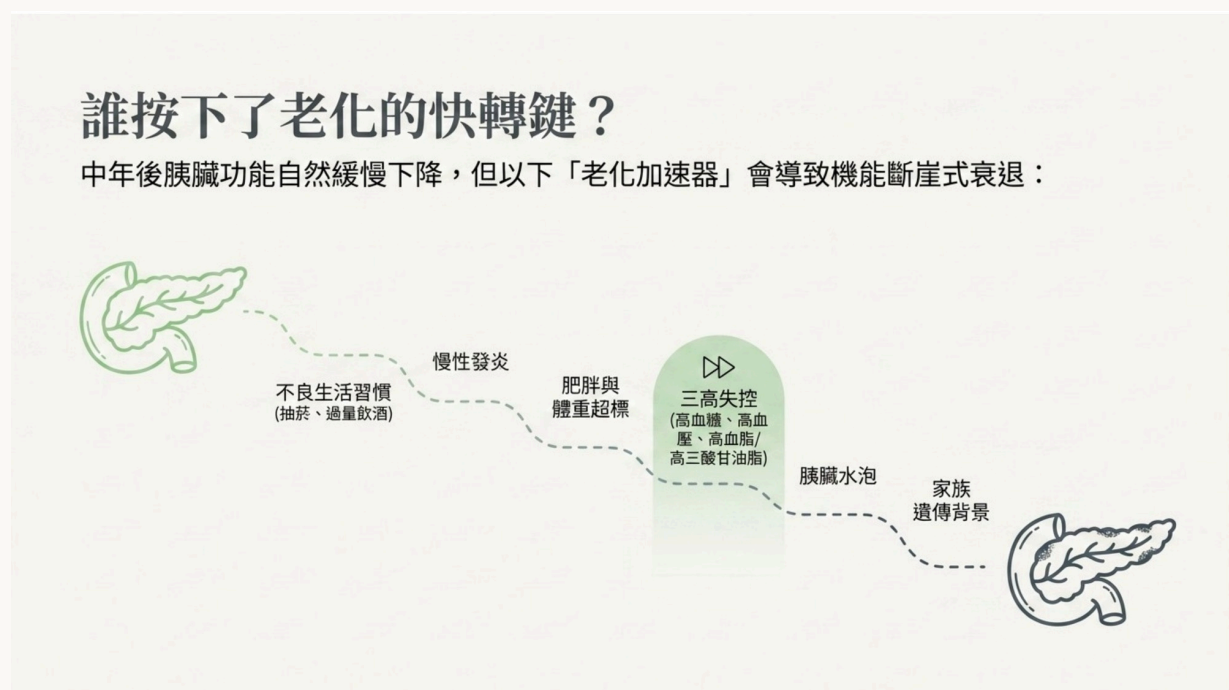
長期應酬喝酒，MRI 顯示胰臟已經鈣化、變形，甚至長了結石。但他的消化與血糖功能目前都還維持在正常範圍（HbA1c 5.8）。

這告訴我們一個殘酷的醫學事實：胰臟的「代償能力」極強。通常要等到功能損失 85% 以上（也就是僅剩 10–15% 活力的殘部），身體才會出現臨床症狀。

當我們在影像上看到胰臟萎縮、脂肪浸潤（脂肪胰）、鈣化點或是胰管擴張變粗時，這通常是老化的特徵，但也可能代表慢性發炎의累積。所以，絕對不能「以貌取胰」，功能檢查與臨床症狀同樣重要。

誰按下了老化的快轉鍵？

中年後，胰臟功能會自然緩慢下降；但以下這些「老化加速器」，卻會讓機能出現斷崖式的衰退。認清它們，是守護胰臟的第一步。



不良生活習慣、慢性發炎、肥胖與體重超標、三高失控、胰臟水泡與家族遺傳，都是按下老化快轉鍵的推手。

五類對象，建議定期做胰臟深度檢查

01 50 歲以上

隨著年齡增長，器官老化是自然規律，50 歲是風險陡升的轉折點。以目前的飲食習慣，可能 40 歲就會提早老化。

02 血糖初次異常或突發惡化

空腹血糖 > 100 或糖化血色素 > 6 時，不要只當成普通糖尿病，要一併排除胰臟疾病。

03 頑固性脹氣與消化不良

長期覺得肚子脹，吃一般消脹氣藥物完全無效，且找不到腸胃方面的原因。

04 不明原因的體重下滑

短期內體重下降超過 5%，且伴隨食慾不振或疲累感。

05 排便習慣改變與油便

出現排便次數增加、不成型，或是糞便帶油。**請注意，一旦出現油便，通常代表胰臟功能已剩下不到 15%！**

I 結語：別讓胰臟成為生命中的遺憾

胰臟藏在身體最深處，它的沉默既是溫柔，也是一種偽裝。但我常說，醫療的進步，是為了讓我們能「看穿偽裝」——有機會在「遺憾」發生前，捕捉到它疲累的身影。

守護健康不需要恐懼，需要的是理性的覺察。別讓「沉默的殺手」帶走你的精彩人生，讓我們從今天起，給予胰臟應有的關注。希望每一位讀者，都能遠離「癌王」的陰影，擁有健康、別有胰憾。

I 常見問題 FAQ

Q 影像檢查正常，就代表胰臟沒問題嗎？

A 不一定。胰臟的代償能力極強，通常要到功能損失 85% 以上才會出現明顯症狀，影像與功能常處於「平行時空」，必須同時參考功能檢查與臨床症狀。

Q 不喝酒的人，就不會有胰臟疾病嗎？

A 不是。除了酒精，腫瘤、免疫系統攻擊、基因遺傳（如 PRSS1 突變）以及高三酸甘油酯都是重要推手，滴酒不沾也不能掉以輕心。

Q 胰臟不好，是不是要完全不碰油？

A 這是常見誤會。除了急性發炎期，長期慢性、功能不全者若過度控油，反而會加劇營養失衡；應在醫師指導下適量補充優質油脂與醫用胰臟酵素。

Q 出現「油便」代表什麼？

A 這是明確警訊。一旦糞便帶油、浮油或不成型，通常代表脂肪酶分泌已嚴重不足，胰臟功能可能僅剩不到 15%，建議儘速就醫評估。

Q 哪些人應該定期做胰臟深度檢查？

A 五類對象：50 歲以上、血糖初次異常或突發惡化、頑固性脹氣與消化不良、不明原因體重下滑，以及排便習慣改變或油便者。

傾聽胰臟的求救聲，從今天開始

如果你或家人符合上述任一項警訊，別把它當成單純的腸胃問題。理性覺察、及早檢查，就是給胰臟最好的保護。

預約胰臟健康評估 →

上一篇

沉默的肝：脂肪肝，其實一直在說話

下一篇

血糖溜滑梯：從飯後想睡，看見胰島素的警訊

本文為衛教資訊分享，內容不能取代專業醫療診斷。若有相關症狀，請諮詢您的醫師。

© 2026 胰臟健康管理・章醫師